

HIDROSADENITIS SUPURATIVA (HS) O HIDRADENITIS SUPURATIVA O ACNÉ INVERSA

Nicolas Juan Pablo Sacanambuy Villota, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Es una enfermedad inflamatoria del folículo pilosebáceo crónica, que cursa con brotes con presencia de forúnculos, nódulos dolorosos o abscesos. Afectan diferentes áreas intertriginosas corporales preferentemente las axilas, las ingles y región anogenital. Existen factores desencadenantes y agravantes como:

El tabaquismo, la obesidad, alteraciones endocrinológicas, el microbioma y las fuerzas de fricción o cizallamiento pueden modificar el curso de la enfermedad.

La hidradenitis supurativa (HS; del griego hidros = sudor y aden = glándulas) es una afección inflamatoria crónica de la piel que también se conoce como acné inverso o enfermedad de Verneuil. Aunque el nombre "hidradenitis supurativa" sugiere un trastorno supurativo que afecta principalmente a las glándulas sudoríparas, el creciente conocimiento de la patogenia de la afección ha llevado a la teoría predominante de que ésta entidad es una enfermedad oclusiva folicular crónica que afecta la porción folicular de las unidades foliculopilosebáceas.

Los principales sitios de afectación son las áreas intertriginosas de la piel de las regiones axilar, inguinal, perianal, perineal e inframamaria, aunque la HS puede ocurrir en cualquier área de la piel que contenga FPSU. Las manifestaciones clínicas varían, desde nódulos y abscesos inflamados recurrentes hasta fistulas cutáneas que drenan anteriormente y bandas de formación de cicatrices graves. El dolor asociado, el mal olor, el drenaje y la desfiguración que acompañan a la Hidrosadenitis Supurativa contribuyen a un profundo impacto psicosocial de la enfermedad en muchos pacientes. Las lesiones tempranas pueden simular otros trastornos; el diagnóstico erróneo de ésta patología con otras enfermedades como forunculosis recurrente o "forúnculos" es común. El reconocimiento rápido del diagnóstico correcto es importante. Un diagnóstico temprano y preciso facilita el inicio de un plan de tratamiento destinado a minimizar el riesgo de progresión, cronificación y que se llegue a etapas avanzadas y graves de la enfermedad.

Las estimaciones de la prevalencia de la HS han variado, desde menos del 1 por ciento hasta el 4 por ciento. La prevalencia en el Reino Unido de un estudio que utilizó el Enlace de datos de investigación de práctica clínica a nivel nacional, que también identificó a personas no diagnosticadas con HS, fue del 0,77 por ciento. El inicio de los síntomas ocurre típicamente entre la pubertad y los 40 años, con un inicio habitual en la segunda o tercera década de la vida. Los estudios de América del Norte y Europa sugieren que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar HS que los hombres.

Patogénesis

La patogenia de la HS no se comprende por completo; sin embargo, está surgiendo nueva evidencia. A diferencia de las primeras teorías que implicaban a las glándulas apocrinas como los principales contribuyentes a la HS, la mayoría de los autores ahora apoyan las teorías centradas en el folículo para la patogenia. La oclusión folicular, la ruptura folicular y

una respuesta inmune asociada parecen ser eventos importantes en el desarrollo de las manifestaciones clínicas.

La oclusión folicular es el evento más probable responsable del desarrollo inicial de las lesiones. La oclusión folicular parece ser el resultado de la proliferación de queratinocitos ductales que causa hiperqueratosis folicular y taponamiento. La anoxia dentro del conducto folicular secundaria a la hiperplasia epitelial folicular contribuye a la interrupción de la diferenciación terminal normal de los queratinocitos foliculares, lo que lleva a la obstrucción folicular.

Como consecuencia del fracaso de la diferenciación terminal, los queratinocitos no se separan y el conducto folicular se expande. El estrés mecánico (presión, fricción o cizallamiento) sobre la piel, en particular en las áreas intertriginosas, provoca la fuga de antígenos de tamaño molecular que estimulan el sistema inmunitario adaptativo, así como estímulos para el sistema inmunitario innato. La liberación posterior de citocinas conduce a la activación de los queratinocitos que liberan sus propios mediadores proinflamatorios. Si no se produce una reparación suficiente del conducto folicular comprometido, el conducto folicular puede eventualmente romperse, lo que lleva a la liberación de contenidos macrofoliculares (p. ej., fragmentos de queratina derivados de corneocitos y cabello, productos de sebo, bacterias) y al reclutamiento adicional de sustancias inflamatorias y células. Con el tiempo, la respuesta inflamatoria aguda inicial evoluciona a una inflamación granulomatosa crónica tipo cuerpo extraño.

La susceptibilidad genética, las tensiones mecánicas en la piel, la obesidad, el tabaquismo, la dieta y los factores hormonales se citan repetidamente como factores que pueden estar asociados con el desarrollo o la exacerbación de esta entidad. La susceptibilidad genética parece ser un factor importante que contribuye a la HS. Se estima que aproximadamente el 40 por ciento de los pacientes con HS tienen un familiar de primer grado afectado.

DIAGNÓSTICO

Dentro del examen físico debemos explorar áreas intertriginosas principalmente las axilas (sitio más común), el área inguinal, la parte interna de los muslos, las áreas perianal y perineal, regiones mamaria e inframamaria, glúteos, región púbica, escroto, la vulva, el tronco y, en ocasiones, el cuero cabelludo y las áreas retroauriculares. Las lesiones visibles primarias de la HS son los nódulos inflamatorios y los abscesos. La formación de fistulas cutáneas, los grupos de comedones abiertos y las cicatrices son el resultado de una enfermedad recurrente o persistente.

Estadificación clínica

El sistema de estadificación clínica de Hurley se utiliza con frecuencia para dividir a los pacientes con HS en tres grupos de gravedad de la enfermedad:

- **Etapa I:** formación de abscesos (únicos o múltiples) sin túneles cutáneos ni cicatrización/cicatrización
- **Etapa II:** abscesos recurrentes con túneles cutáneos y cicatrices, lesiones únicas o múltiples muy separadas
- **Etapa III:** afectación difusa o casi difusa, o múltiples túneles cutáneos interconectados y abscesos en toda el área

Reducción de la carga de la enfermedad : las terapias comunes para reducir la carga de la enfermedad en la HS leve incluyen clindamicina tópica, tetraciclinas orales, agentes antiandrogénicos y metformina .

Los pacientes que no logran controlar la enfermedad con clindamicina tópica son candidatos para la terapia oral. Las tetraciclinas orales se prescriben con frecuencia. Los medicamentos antiandrogénicos y la metformina son opciones de tratamiento adicionales que se pueden usar solos o junto con la terapia con antibióticos. Algunos autores han sugerido que las pacientes que experimentan brotes de HS en asociación con la menstruación o que tienen características del síndrome de ovario poliquístico pueden tener más probabilidades de beneficiarse de los fármacos antiandrogénicos.

Enfermedad refractaria : los pacientes con HS leve que no mejora con los tratamientos anteriores pueden beneficiarse de algunas de las terapias utilizadas para enfermedades más graves. En general, la terapia combinada de clindamicina y rifampicina, acitretina y dapsona se consideran opciones sistémicas apropiadas para esta población. La terapia con láser de granate de itrio y aluminio dopado con neodimio (Nd:YAG) también se ha utilizado en este contexto. El tratamiento con agentes biológicos, antibióticos intravenosos y terapias inmunosupresoras generalmente se reservan para pacientes que presentan una enfermedad más grave.

Corticosteroides intralesionales : la inyección de corticosteroides intralesionales implica la inyección de un corticosteroide, como el acetónido de triamcinolona , directamente en un nódulo inflamatorio. Por lo general, usamos acetónido de triamcinolona en una concentración de 10 mg/mL e inyectamos entre 0,2 y 1 mL en nódulos individuales, y la cantidad inyectada depende del tamaño del nódulo. La mejora notable en los síntomas a menudo ocurre dentro de uno o dos días.

La mayoría de los pacientes con HS presentan enfermedad en estadio I. En una serie francesa de 302 pacientes consecutivos con HS, se observó enfermedad en estadio I, II y III en el 68, 28 y 4 por ciento de los pacientes, respectivamente.

Historia y examen físico: las tres características clínicas principales que respaldan un diagnóstico de HS son las siguientes:

- Lesiones típicas (múltiples nódulos inflamados profundos, comedones tombstone, túneles cutáneos, abscesos y/o cicatrices fibróticas)
- Ubicaciones típicas (en particular, axilas, ingles, áreas inframamarias; distribución a menudo bilateral)
- Recaídas y cronicidad los médicos deben mantener una alta sospecha para el diagnóstico de todos los pacientes que presentan nódulos inflamatorios recurrentes, particularmente cuando hay compromiso intertriginoso. El reconocimiento de esta característica y los patrones característicos de cicatrización pueden permitir el tratamiento de la enfermedad en etapas tempranas. El inicio en la adolescencia o la edad adulta joven, los antecedentes de enfermedad recurrente o persistente, o los antecedentes familiares de HS ofrecen apoyo para el diagnóstico.

TRATAMIENTO

Existen numerosas intervenciones para el tratamiento de la HS, incluidas terapias tópicas, terapias orales, terapias biológicas, cirugía e intervenciones con láser y luz. La gravedad de la enfermedad, la tolerancia del paciente a agentes específicos, las comorbilidades y el costo y la disponibilidad del tratamiento guían la selección del tratamiento.

Las intervenciones para la HS se enfocan en uno o más de tres objetivos principales:

- Para reducir la formación de nuevas lesiones inflamatorias, túneles cutáneos y cicatrices.
- Para tratar lesiones existentes y reducir los síntomas asociados (p. ej., dolor, supuración)
- Para minimizar la morbilidad psicológica asociada

La HS es un trastorno psicológicamente angustiante que puede tener un gran impacto en la calidad de vida y, a menudo, se asocia con varios años o más de retraso en el diagnóstico, lo que hace que la educación y el apoyo del paciente sean componentes esenciales del tratamiento, se debe:

- Educar a los pacientes sobre el diagnóstico de la HS. Normalmente comunicamos lo siguiente:

- La HS es una afección inflamatoria crónica que no es contagiosa ni se debe a una higiene deficiente.

- Aunque la HS se ha asociado con el tabaquismo y la obesidad, la HS también puede ocurrir en ausencia de estas características.

- El curso de la HS varía de persona a persona; No se han identificado predictores fiables de progresión a una enfermedad más grave. Desbridamiento con sacabocados : el destechamiento quirúrgico es un procedimiento en el que se extrae la piel que recubre un nódulo inflamado o un túnel cutáneo y se permite que la herida resultante cicatrice por segunda intención. El desbridamiento con sacabocados (destechado parcial) es un subtipo menor de destechado quirúrgico que consiste en la utilización de una herramienta de biopsia con sacabocados para evacuar nódulos inflamados agudos que están centrados alrededor de una sola unidad foliculopilosebácea. El uso de esta técnica se basa en la experiencia clínica.

Incisión y drenaje : la incisión y el drenaje pueden promover la recurrencia de la lesión y no se recomiendan para el tratamiento de rutina de lesiones agudas de HS. El procedimiento debe limitarse a situaciones en las que es necesario el alivio inmediato del dolor intenso de un nódulo fluctuante e inflamado y el tratamiento con otras técnicas no es factible.

TERAPIA BIOLÓGICA

Adalimumab: el programa de dosificación recomendado para adultos con HS es una dosis subcutánea inicial de 160 mg (administrada una vez o dividida en dos dosis de 80 mg administradas durante dos días consecutivos), luego 80 mg el día 15 y luego 40 mg una vez a la semana comenzando el día 29. En 2020, la etiqueta de la FDA para adalimumab se actualizó para incluir 80 mg cada dos semanas como alternativa a 40 mg semanales. Dada la mayor cantidad de evidencia que respalda el régimen de 40 mg una vez a la semana, generalmente recetamos 40 mg una vez a la semana.

Infliximab: el régimen óptimo no está claro. Por lo general, tratamos con un régimen de dosificación similar al régimen estándar para la psoriasis (5 mg/kg en las semanas 0, 2, 6 y luego cada ocho semanas). Sin embargo, hay observaciones clínicas que sugieren que una dosificación más frecuente que la utilizada para la psoriasis puede ser beneficiosa para la HS (5 mg/kg en las semanas 0, 2, 6 y luego cada cuatro semanas en lugar de cada ocho semanas)

ENFERMEDAD REFRACTARIA GRAVE

para pacientes en estadio Hurley III, la escisión amplia puede ser beneficiosa.

Escisión amplia : se considera que la intervención quirúrgica extensa ofrece la mayor probabilidad de resolución de la inflamación activa en el área tratada. Cabe destacar que el procedimiento puede desfigurar e implicar un tiempo de recuperación prolongado. Además, la escisión extensa no suele ser factible en pacientes con múltiples regiones cutáneas afectadas. Los datos que respaldan la escisión amplia son limitados y consisten principalmente en datos de estudios no controlados.

BIBLIOGRAFIA

- Melnik BC, Plewig G. Impaired Notch signalling: the unifying mechanism explaining the pathogenesis of hidradenitis suppurativa (acne inversa). Br J Dermatol 2013; 168:876.
- Nazary M, van der Zee HH, Prens EP, et al. Pathogenesis and pharmacotherapy of Hidradenitis suppurativa. Eur J Pharmacol 2011; 672:1.
- Canoui-Poitrene F, Revuz JE, Wolkenstein P, et al. Clinical characteristics of a series of 302 French patients with hidradenitis suppurativa, with an analysis of factors associated with disease severity. J Am Acad Dermatol 2009; 61:51.
- Ring HC, Thorsen J, Saunte DM, et al. The Follicular Skin Microbiome in Patients With Hidradenitis Suppurativa and Healthy Controls. JAMA Dermatol 2017; 153:897.
- Jemec GB. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012; 366:158.
- Dauden E, Lazaro P, Aguilar MD, et al. Recommendations for the management of comorbidity in hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32:129.
- Nazary M, van der Zee HH, Prens EP, et al. Pathogenesis and pharmacotherapy of Hidradenitis suppurativa. Eur J Pharmacol 2011; 672:1.
- Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L, et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015; 29:619.